



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض رباعياً : سحر سمير السيد احمد

المحافظة : القاهرة

الحي / المدينة : اخري

العنوان : قريه اتريس منشاه
القناطر

رقم البطاقة : 27809170101664 رقم التليفون : 01146678686

تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 17-09-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر سمير السيد احمد National ID: 27809170101664	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



رقم الطلب

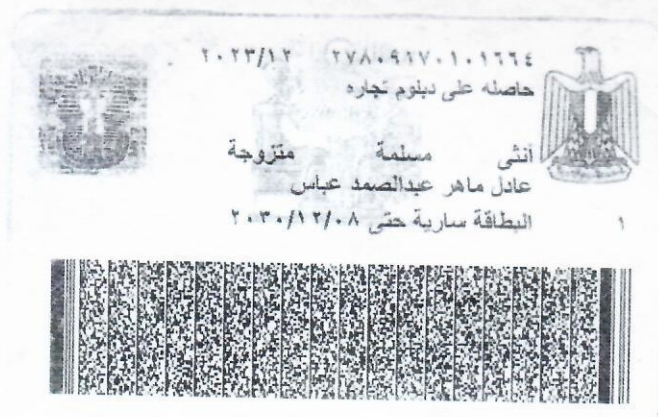
٦٧٦٤١٣٠٢

تاريخ النسخ

١١/٣

نصف طلب العبد

وي رفع طلب اللاجئ



١١٥٦٦٤٤٦٤٩

١١٤٦٦٧٨٦٨٦

ما هو + عينة

٨/٩٥

تعرفني على كيفية إد

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأخذي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

طفح
حادث جوف
تغير في الشكل
تغير في الحجم
بروز الأوردة

تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
تجاعيد بالجلد
قشر البرتقال
تحول الجلد لما يشبه

الخطوة الثانية (أمام المرأة)
أرفعي يديكي إلى أعلى وتأخذي من عدم وجود أي من التغيرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم

الاسم: محمد عبد الله
الرقم القومي: ٥٧٨٩١٧٠١٠١٢٦٤
رقم التليفون: ٠١١٤٦٧٧٨٦٨٦

مستهدفة بالتوعية

مستهدفة بالتوعية والفحص الإكلينيكي

اللون	الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر العشوائي	قياس ضغط

* فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

يوليو 2019	أغسطس 2019	سبتمبر 2019	أكتوبر 2019	نوفمبر 2019	ديسمبر 2019
يناير 2020	فبراير 2020	مارس 2020	أبريل 2020	مايو 2020	يونيو 2020
يوليو 2020	أغسطس 2020	سبتمبر 2020	أكتوبر 2020	نوفمبر 2020	ديسمبر 2020
يناير 2021	فبراير 2021	مارس 2021	أبريل 2021	مايو 2021	يونيو 2021

- حافظي على قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، إستشيري بالنظام طبيب تنظيم الأسرة.
إعلمني، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

موعد الفحص القادم:
المكان المحولة له للتقييم:
توقيع الطبيب:
موعد التقييم:

15335

www.100millionseha.org



رسوم الاستعلام 20 جنية

جهاز الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-8-25

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) سحر سمير السيد بطاقة رقم 27809170101664
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-8-25

الموظف المختص

كريمه ابراهيم

افادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،



مسلسل 2060114

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي

اسم المريض بالإنجليزية: Sahar Samir Alsid Ahmed	كود المريض: 98725
تاريخ التقرير: 2026/08/25 01:18:11 PM	السن: ٤٧ سنة, ١١ شهر

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: left lump & skin , nipple changes

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated normal parenchyma
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

• Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ & central & to less extent UIQ asymmetry , distortion extend from nipple to posterior third of the breast with overlying suspicious microcalcifications measures 9.6x8.5x7cm
- Diffuse skin thickness & nipple retraction
- Ultrasound 10-4:00 diffuse pathological process in form of area of altered parenchyma, shadowing, mounting to mass forming.
- Level I 2 pathological axillary nodes, the largest measures 1.3x0.8cm with cortical thickness 0.6cm & axillary tail 2 pathological nodes

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal

Left breast (BIRADS 5): 10-4:00 diffuse pathological process, highly suggestive of malignancy, US guided biopsy taken at clinical setting

DR. Marwa Ramzy, MD, FRCP

جمهورية الكويت - الكويتية
بطاقة تحقيق الشخصية

سجل
سمير السيد احمد
قرية الزبير
منطقة القلطر - الجيزة

٢٧٨٠٩١٧٠١٠١٦٦٤

KH5825197

١١٥١٦٥٢٦٤٩
١١٤٦٦٧٨١٨٦١

عبد الله محمد

٢٠٢٣/٨٢ ٢٧٨٠٩١٧٠١٠١٦٦٤
حصله على بطون تجاره

متروجة
انتش
عادل ماهر عبد الصمد عيسى
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٢/٠٨

١

اسم المريض بالإنجليزية: Sahar Samir Alsid Ahmed	كود المريض: 98725
تاريخ التقرير: 2026/08/25 01:18:11 PM	السن: ٢٧ سنة, ١١ شهر

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: left lump & skin , nipple changes

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated normal parenchyma
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

• Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ & central & to less extent UIQ asymmetry , distortion extend from nipple to posterior third of the breast with overlying suspicious microcalcifications measures 9.6x8.5x7 cm
- Diffuse skin thickness & nipple retraction
- Ultrasound 10-4:00 diffuse pathological process in form of area of altered parenchyma, shadowing, mounting to mass forming.
- Level I 2pathological axillary nodes, the largest measures 1.3x0.8cm with cortical thickness0.6cm & axillary tail 2 pathological nodes

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal

Left breast (BIRADS 5): 10-4:00 diffuse pathological process, highly suggestive of malignancy, US guided biopsy taken at clinical setting

Dr. Marwa Ramezy, MD, FRCR



N I T A I R I

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: السيد أحمد

Age: 48 years

Sex: female

Request type: ميلارد

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.: 870-2026

Department: صدر

Date of result: 5/9/2026

Referred by: د/مروان رمزي

Date of biopsy: 26/8/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number: 27809170101664

Clinical diagnosis: left breast mass

Gross pathology:

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Section examined revealed breast core tissue showed cords, files and descohesive cells of moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among fibrotic stroma with focal fibrocystic changes and mild lymphocytic response. Also seen lobular carcinoma insitu of intermediate grade with microcalcification.

Immunohistochemical Result:

ER: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8

Her2: Weak incomplete membranous staining in < 10% of tumor cells (score 0) extra low

Ki67: Positive nuclear staining of 5% of tumor cells.

Diagnosis: left breast mass, Tru-Cut Biopsy:

Provisional mammary core of Invasive Lobular Carcinoma, Grade II.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

اسم المريض بالإنجليزية: Sahar Samir Alsid Ahmed	كود المريض: 98725
تاريخ الفحص: 2026/08/25 01:18:11 PM	السن: ٤٧ سنة ١١ شهر

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: left lump & skin , nipple changes

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated normal parenchyma
- No solid or cystic lesion
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

• Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ & central & to less extent UIQ asymmetry , distortion extend from nipple to posterior third of the breast with overlaying suspicious microcalcifications measures 9.6x8.5x7cm
- Diffuse skin thickness & nipple retraction
- Ultrasound 10-4:00 diffuse pathological process in form of area of altered parenchyma, shadowing, mounting to mass forming.
- Level 1 2pathological axillary nodes, the largest measures 1.3x0.8cm with cortical thickness0.6cm & axillary tail 2 pathological nodes

Impression:

Right breast (BIRADS 1): Normal

Left breast (BIRADS 5): 10-4:00 diffuse pathological process, highly suggestive of malignancy, US guided biopsy taken at clinical setting

Dr. Marwa Gamay, MD, FRCR

تعرفني على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لكي دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين :

بروز الأوردة تغير في الشكل أو الحجم حدوث تجوف طفح

تجاعيد بالجلد تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال الإحمرار تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة تقرحات بالجلد أو الحلمة

الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- ارفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغيرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

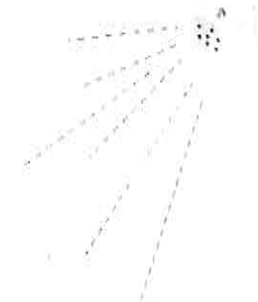
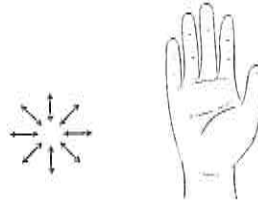
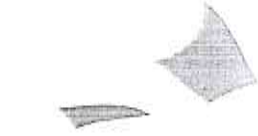
إفرازات غير طبيعية أو دم

الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- أعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

في حال ملاحظة أي من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

- أفضل توقيت لتقومي بالفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة انقطاع الدورة الشهرية حددتي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.



الخطوة الرابعة (على السرير)

- استلقي على السرير، استخدم يدي اليمنى لفحص الثدي الأيمن واليد اليسرى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبدأ من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلي إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام

ورم محسوس

آلم بالثدي

